

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

Région : Estrie
Dossier : 552849-05-1409
Dossier CNESST : 142212703
Assesseur : Daniel Couture, médecin

Sherbrooke, le 11 mars 2016

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : Jacques Degré

Sabrina Nadeau
Partie demanderesse

et

Emballage Hood Corporation
Partie défenderesse

DÉCISION

[1] Le 25 septembre 2014, madame Sabrina Nadeau (la travailleuse) porte en appel, devant la Commission des lésions professionnelles, une décision de la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 septembre 2014.

[2] Cette décision infirme celle rendue le 5 juin 2014 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 18 février 2014.

[3] Le 1^{er} janvier 2016, la *Loi instituant le Tribunal administratif du travail*¹ (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l'article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[4] De plus, depuis le 1^{er} janvier 2016, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.

[5] Dans le présent dossier une première journée d'audience fut tenue le 6 octobre 2015 à Sherbrooke devant le commissaire Jacques Degré, juge administratif à la Commission des lésions professionnelles, qui était alors accompagné de madame Nicole Girard, membre issu des associations d'employeurs, et de monsieur Jacques Généreux, membre issu des associations syndicales. L'article 260 de la LITAT prévoit que le mandat des membres autres que les commissaires prenait fin le 31 décembre 2015 et que ces membres ne termineraient pas les affaires qu'ils avaient commencées. Comme l'affaire n'était pas terminée en date du 31 décembre 2015, l'avis des membres issus des associations syndicales et d'employeurs n'a pas à être rapporté.

[6] La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.

[7] L'audience du 6 octobre 2015 s'est tenue en présence de la travailleuse et son représentant, de même qu'en présence du représentant d'Emballage Hood Corporation (l'employeur), monsieur Claude Racette, et de sa procureure. L'affaire fut ajournée en raison de l'heure tardive et les parties ont présenté leur argumentation respective devant le Tribunal administratif du travail le 11 janvier 2016. L'affaire fut placée en délibéré au terme de cette audience.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[8] La travailleuse demande de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 18 février 2014, une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche, sous la forme d'un accident du travail, selon l'interprétation élargie de cette notion.

¹ RLRQ, c. T-15.1.

LA PREUVE

[9] La travailleuse, une droitière, est au service de l'employeur depuis le mois d'août 1999.

[10] Le 5 mars 2014, âgée de 32 ans, et alors qu'elle occupe le poste « inspecteur Weber », elle entre une inscription au registre des accidents. Elle note qu'elle ressent une douleur à l'épaule gauche depuis deux semaines qui ne s'améliore pas et indique avoir utilisé Voltaren et avoir eu de la massothérapie thérapeutique (pièce T-1).

[11] Le 14 mars 2014, la travailleuse consulte son médecin, docteur Baril, omnipraticienne. Le médecin note que la travailleuse rapporte une douleur à l'épaule gauche apparue progressivement il y a un mois, sans accident, à la suite de mouvements répétés au travail, « *paquets de sacs de 6 à 10 lb, mais large, donc toujours en abduction, 75°, pour les prendre* » (pièce T-3). Après examen, docteur Baril pose le diagnostic de tendinopathie du sus-épineux gauche pour laquelle elle prescrit la mise au repos du membre supérieur gauche pour 14 jours, de la physiothérapie, et autorise l'assignation temporaire offerte par l'employeur.

[12] Le même jour, la travailleuse remplit un *Rapport d'enquête* et indique :

Le 18 février la commande que l'on avait n'allait pas bien, je jettais 3-4 sacs par paquet de 15 sacs. L'opérateur a gardé la même vitesse. Alors pendant cette soirée, avec la vitesse et les mouvements répétés, j'ai ressenti une douleur à l'épaule gauche. Suite à cette douleur, j'ai utilisé du Voltaren et les services d'un massothérapeute. Les douleurs étaient soulagées mais en revenant au travail, avec les mêmes mouvements, la douleur est revenue. J'ai été voir un chiropraticien, encore la même chose, soulagement temporaire. Le 5 mars, j'ai déclaré ma situation car j'avais de plus en plus de difficulté à faire certains mouvements. Le 14 rencontre avec mon médecin, arrêt de travail.
[sic]

[13] Le 17 mars, la travailleuse remplit un formulaire de réclamation qu'elle dépose à la CSST quelques jours plus tard.

[14] Le 20 mars, docteur Léger, médecin-conseil de l'employeur, examine la travailleuse. Le médecin note que la travailleuse rapporte avoir eu un changement d'affectation depuis sept semaines à l'inspection des sacs avec apparition progressive d'une douleur à la face postéro-externe de l'épaule gauche vers le 18 février, sans souvenir d'un traumatisme à la suite duquel la douleur aurait débuté, sans impact ou faux mouvement associé. Docteur Léger écrit que la travailleuse déclare qu'elle relève des paquets de sacs de côté, dont le poids varie entre six et 10 lb, et que ses bras sont maintenus plus bas que la hauteur des épaules. Au chapitre des antécédents, il note qu'elle a présenté une tendinite à l'épaule gauche en 2000 qui a duré plusieurs mois, traitée par physiothérapie, sans infiltration ni imagerie, avec récupération sans séquelle.

[15] À l'examen, il y a un point douloureux au chef postérieur du deltoïde gauche. Les mouvements actifs de l'épaule gauche se complètent, sans évidence d'accrochage, l'abduction seule étant douloureuse. Le médecin conclut à un diagnostic de myalgie du chef postérieur du deltoïde gauche sans évidence de tendinite de la coiffe des rotateurs.

[16] Relativement à la relation causale, docteur Léger retient que la travailleuse n'a pas à travailler avec les bras plus haut que la hauteur des épaules et que la charge n'est pas lourde. En raison de ces observations, il indique qu'il n'existe pas de relation entre le travail effectué et le diagnostic éventuel de tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

[17] Le 7 avril, docteur Baril recommande de favoriser la reprise d'efforts physiques dans le cadre de l'assignation temporaire de la travailleuse, sans toutefois augmenter la cadence. Le 9 mai, elle note une amélioration de plus de 80 % de la douleur et de la mobilité et prolonge l'assignation temporaire ainsi que la physiothérapie.

[18] Le 26 mai, une agente de la CSST communique avec la travailleuse aux fins du traitement de sa réclamation. L'agente note que la travailleuse rapporte qu'elle n'avait aucune douleur à l'épaule gauche à son arrivée au travail le 18 février, qu'en cours de soirée, il y avait beaucoup de rejets de produits et que contrairement à l'habitude, l'opérateur n'a pas diminué la cadence de la machine, ce qui l'a amené à travailler plus vite. L'agente indique que la travailleuse déclare qu'à un certain moment elle a senti une brûlure dans l'épaule gauche.

[19] L'agente de la CSST note que sur une vidéo dont elle dispose, mais qui ne met pas en scène la travailleuse, la personne reçoit une pile de sacs (d'un poids variant de six à 10 lb, selon ce que lui rapporte la travailleuse), et que cette personne, dans un mouvement d'abduction et de flexion des épaules, prend les sacs dont le fond est du côté gauche. L'agente note que lorsque les fonds de sacs sont du côté droit, le mouvement en est un d'extension du bras gauche avec adduction.

[20] Lors d'un entretien avec l'employeur tenu quelques jours plus tard, l'agente de la CSST note que celui-ci rapporte que le 18 février le quart de travail de la travailleuse était de 15 h à 1 h et que le taux de rejet pour le quart fut de 10 % (2 111 sacs), alors que le taux moyen est habituellement de l'ordre de 3 %.

[21] Le 5 juin, la CSST informe donc la travailleuse de l'admissibilité de sa réclamation pour l'accident subi le 18 février 2014 et qui lui a causé une tendinopathie de l'épaule gauche.

[22] Le 20 juin, docteur Baril constate une augmentation de l'endurance musculaire et le 24 juillet, elle autorise un retour progressif au travail.

[23] Le 12 septembre, après une demande de révision déposée par l'employeur, la Direction de la révision administrative de la CSST retient que la lésion n'est pas associée à un traumatisme subi le 18 février et que les délais pour déclarer, consulter et cesser le travail ne permettent pas de conclure que la lésion est survenue par le fait ou à l'occasion du travail. La réviseure conclut que la relation entre l'événement et la lésion n'est pas démontrée et infirme la décision du 5 juin.

[24] Le 25 septembre, la travailleuse porte la décision du 12 septembre en appel devant la Commission des lésions professionnelles.

[25] Le 2 octobre, docteur Baril produit le *Rapport final* et consolide, sans séquelle et avec suffisance de soins et traitements, un syndrome d'accrochage de la coiffe des rotateurs post tendinopathie du sus-épineux.

[26] À l'audience du 6 octobre 2015, le Tribunal a d'abord visionné une vidéo mettant en scène la travailleuse au poste de travail inspecteur Weber. Il fut permis de constater qu'au moment de retourner (*flipper*) une pile de sacs, mouvement qu'elle tient pour principal responsable de sa lésion, la travailleuse exécute une flexion antérieure, abduction et rotation interne du membre supérieur gauche, de 45 à 85°.

[27] Il fut démontré que la travailleuse a occupé le poste inspecteur Weber du 27 janvier au 14 mars 2014.

[28] Il fut démontré que pour la semaine du 2 janvier au 1^{er} février la production fut de 93 780 sacs, pour la semaine du 2 au 8 février 53 040, pour la semaine du 9 au 15 février 71 350, et pour la semaine du 16 au 22 février, 68 720 (pièce T-4, sommaire de la production par employé par département).

[29] Il fut démontré que le 18 février 2014, la production totale pour les quarts de travail de jour et de soir fut de 19 275 sacs, soit 6 675 sur le quart de jour et 12 600 sur le quart de soir, et que le nombre de rejets total pour les deux quarts fut de 2 111 sacs (pièce E-2).

[30] Il fut admis que les sacs manipulés durant le quart de travail de soir le 18 février 2014 avait un poids unitaire de 0,18672 kg. Les sacs étant manipulés par paquets de 12 ou 13, chaque paquet pèse 2,24 kg.

[31] Il fut admis que l'autre type de sac produit par l'entreprise est manipulé par paquet de quinze, pour un poids de trois kg par paquet.

[32] Il fut démontré que sur le quart de travail de soir le 18 février 2014 la machine fut en arrêt durant 2 heures (*down time*), en marche durant 3,5 heures (*run time*), et a nécessité 4,5 heures de mise en train (*setup*) (pièce E-2).

[33] Dans le cadre de son témoignage, la travailleuse explique que vers la fin de l'année 2013 le travail avait diminué et qu'en fonction de son ancienneté dans l'entreprise elle fut affectée à la machine Weber (inspection) à compter du mois de janvier 2014 pour une période de sept semaines consécutives. Elle précise que le mouvement de *flip* dont elle tient responsable sa lésion à l'épaule gauche n'a pas à être exécuté lorsqu'elle est affectée à d'autres machines.

[34] Elle affirme qu'avant de débiter son quart de travail à 15 h l'après-midi du 18 février 2014, elle n'avait aucun problème à l'épaule gauche. La travailleuse mentionne qu'il y avait beaucoup de rejets et que la cadence de la machine est demeurée constante. Elle déclare que le nombre de rejet, trois ou quatre par paquet, n'influençait pas sa façon d'exécuter le mouvement de *flip* ou le nombre de fois qu'elle devait l'exécuter, mais que cela l'amenait à l'exécuter avec plus de rapidité. Elle affirme qu'à la fin du quart, elle ressentait une douleur sous forme de brûlure, d'une intensité qu'elle évalue à 7/10. Elle dit avoir appliqué un crème analgésique une fois chez elle, croyant à un problème musculaire.

[35] Après le 18 février, la travailleuse affirme avoir modifié sa façon de « *flipper* » les paquets de sacs et isole une séquence sur la vidéo afin de l'illustrer. À cette occasion, le Tribunal constate que la travailleuse exécute toujours une flexion antérieure d'environ 85° de l'épaule gauche, ainsi qu'une rotation interne.

[36] La travailleuse déclare qu'elle a pu exécuter son quart de travail normalement le 19 février, et qu'entre le 25 février et le 14 mars, alors affectée au quart de jour, elle a aussi pu exécuter son travail, notamment parce qu'elle avait modifié sa technique, en raison du nombre moins important de rejet et des temps de *setup*. Constatant la persistance de la douleur, elle dit s'être frictionnée avec du Voltaren et avoir consulté tour à tour massothérapeute et chiropraticien, mais que le soulagement était toujours temporaire, d'où l'inscription du 5 mars au registre des accidents et la consultation du 14 mars.

[37] La travailleuse termine en disant ne pas pratiquer d'activité ou de sport à risque pour son épaule gauche et qu'elle a eu une tendinite à l'épaule gauche, en 2000 ou 2001, pour laquelle elle fut en assignation temporaire durant environ huit semaines.

[38] À la procureure de l'employeur, la travailleuse dit que durant le *down time*, il n'y a pas de production et qu'elle exécute d'autres tâches. Elle ajoute que cette période inclut ses deux pauses de 15 minutes et sa période de repas de 30 minutes. Quant au temps de *setup*, la travailleuse dit qu'il inclut des temps morts et aussi des temps de *waste*.

Elle ajoute qu'elle calcule la période de sept semaines consécutives au cours de laquelle elle fut affectée à la machine Weber (inspection) en comptant à rebours sept semaines à partir du 14 mars.

[39] Au Tribunal, la travailleuse précise qu'elle exécute le mouvement de *flip* tant avec son membre supérieur gauche qu'avec le membre supérieur droit, et ce, dans une proportion d'environ 50 % de chaque côté.

[40] Dans le cadre de l'administration de la preuve de l'employeur, le Tribunal a entendu monsieur Racette, coordonnateur de l'entreprise depuis le mois d'avril 2010, qui a expliqué la signification des données contenues au rapport de production pour la journée du 18 février 2014 (pièce E-2). Ce dernier a notamment précisé que les 3,5 heures de *run time* étaient cumulatives et non consécutives.

[41] Contre interrogé, le témoin a précisé que le total de 2 111 rejets pour les deux quarts de travail du 18 février 2014 n'incluait pas les rejets du *setup* et qu'il en ignorait le nombre. Monsieur Racette déclare de plus qu'il est probable qu'il y ait eu davantage de rejet durant le quart de soir que durant le quart de jour.

[42] L'employeur a ensuite fait entendre docteur Léger.

[43] Le médecin explique qu'un mouvement à risque pour développer une tendinopathie du sus-épineux implique une abduction ou en élévation antérieure dans un angle de 90° et plus, entraînant une diminution de l'espace sous-acromial et ainsi un espace plus restreint pour le tendon. Outre l'angle dans lequel est exécuté le mouvement, le témoin affirme, que sur le plan ergonomique, le poids manipulé, des temps de repos insuffisant et une posture contraignante sont autant de facteurs de risque, facteurs qu'il dit ne pas avoir observés dans le cas de la travailleuse, considérant entre autres éléments la durée de la séquence de production du 18 février 2014. Docteur Léger ajoute que le cycle de travail de la travailleuse implique plusieurs gestes différents, sans gestes à risque exécutés de façon successive, diminuant ainsi d'autant le risque de développer une tendinopathie.

[44] Quant au mouvement de *flip*, référant notamment au jeu de photos tirées de la vidéo, le médecin retient que même si exécuté dans un angle de près de 90°, ce mouvement ne va pas au-delà d'un geste physiologique et est exécuté sans amplitude extrême ni poids important.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[45] Le représentant de la travailleuse soumet d'abord que le poste occupé par cette dernière, à compter de janvier 2014, en est un occasionnel ou temporaire pour elle. Il rappelle que le 18 février 2014, il y a eu une quantité plus importante de rejet qu'à

l'habitude et que le rapport de production déposé en preuve n'inclut pas les rejets du *setup*. Le représentant allègue que le 18 février 2014 la travailleuse est asymptomatique, que la manipulation des paquets de sacs implique un mouvement dans une amplitude au-delà de 60°, et qu'elle a déclaré dès le 5 mars la douleur qui s'est installée le 18 février précédent, pour consulter ensuite rapidement. Le représentant de la travailleuse explique le fait que la travailleuse ait pu demeurer au travail dans l'intervalle entre autres par le fait qu'elle a modifié sa façon de travailler. Pour le représentant, la tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche résulte d'une surcharge de travail qui survient dans un contexte de travail inhabituel pour la travailleuse, à l'intérieur d'une période circonscrite dans le temps. Il demande d'infirmier la décision rendue le 12 septembre 2014 et rétablir celle initialement rendue le 5 juin 2014. Le représentant dépose et commente ensuite deux extraits tirés de deux livres de référence médicale² et une copie tirée du site web du Gouvernement du Canada (Trouble tendineux).

[46] La procureure de l'employeur soumet qu'en l'espèce le diagnostic de tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche ne saurait constituer un diagnostic de blessure en raison du contexte de mouvements répétés en cause, de l'apparition progressive de la douleur, et de l'absence de traumatisme clairement défini pour l'expliquer. Elle argue qu'en pareilles circonstances, il y a tout lieu de conclure à la manifestation d'une condition personnelle au travail que la travailleuse, en toute bonne foi, relie à son travail. L'avocate plaide que le fardeau de preuve de la travailleuse implique, selon l'angle adopté pour expliquer sa lésion, la preuve d'une sollicitation importante du site lésé dans une amplitude indue et non physiologique, dans un contexte de travail inhabituel ou de changement majeur, en plus identifier le geste causal de façon spécifique. En l'absence d'une preuve de nature médicale sur la question, elle plaide que le seul témoignage de la travailleuse et le dépôt de littérature est insuffisant pour conclure que cette dernière a assumé son fardeau de preuve.

[47] La procureure soumet qu'il est généralement reconnu que des gestes dans une amplitude de plus de 60°, et surtout plus de 90°, constituent un facteur de risque dans le cas de tendinopathie de l'épaule. Elle souligne qu'en l'espèce la travailleuse a reconnu qu'elle exécutait le seul mouvement qu'elle identifie comme étant à l'origine de sa lésion tant de la droite que de la gauche. En présence d'une lésion unilatérale, d'un *run time* de 3,5 heures et de l'exécution de mouvements variés, la procureure voit dans ces éléments autant de signes de la manifestation d'une condition personnelle au travail. L'avocate plaide que l'opinion du docteur Léger sur l'absence de relation causale entre le mouvement de *flip* et le diagnostic de tendinopathie du sus-épineux de

²

Jeanne Mager STELLMAN, *Encyclopédie de sécurité et de santé au travail*, 3^e éd. française, Genève, Bureau international du travail, 2004; *Pathologie médicale de l'appareil locomoteur*, 2^e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.

l'épaule gauche n'est pas contredite, et conclut au rejet de la contestation de la travailleuse. Elle dépose 14 décisions au soutien de ses prétentions³.

LES MOTIFS

[48] Le Tribunal administratif du travail doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 18 février 2014, une tendinopathie du sus-épineux à l'épaule gauche, sous la forme d'un accident du travail selon l'interprétation élargie de cette notion, comme développée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

[49] La *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*⁴ donne les définitions suivantes des expressions accident du travail et lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« **accident du travail** » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

« **lésion professionnelle** » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récurrence, la rechute ou l'aggravation;

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[50] La travailleuse ne prétend pas être atteinte d'une maladie professionnelle ni avoir subi une récurrence, rechute ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure. Soulignons à tout événement qu'en fonction de la preuve administrée il n'aurait certes pas été permis de conclure de façon probante que la travailleuse est atteinte d'une

³ Brunet et *La Cité de la santé de Laval*, 2015 QCCLP 2954; *Rodrigue et Chemins de fer nationaux du Canada*, 2013 QCCLP 6598; *Díaz-Herrera et Bistro Express Sandwicherie*, 2012 QCCLP 5814; *Lizotte et The Business Depot Ltd*, 2012 QCCLP 1826; *Laflamme et CSSS du Grand Littoral*, 2009 QCCLP 7071; *Guimond et Cégep du Vieux-Montréal*, 2007 QCCLP 7342; *Smith et Alcoa-Teck inc. et Métallurgie Brasco enr. et CSST*, 263908-32-0506, 31 mars 2006, A. Tremblay; *P.P.G. c. CALP*, 29 mars 2001, D.T.E. 2001T-369, Montréal (C.A.); *Olymel S.E.C. (Princeville) et Ortiz*, 2011 QCCLP 4098; *CSSS du Grand Littoral et Desbiens*, 2011 QCCLP 6021; *Olymel Vallée Jonction*, 2008 QCCLP 4780; *Lapointe et Démolition JPM inc.*, 2007 QCCLP 4777; *Fabricant de poêles international et Thomassin*, 5 octobre 2004, AZ-50274431, Québec, G. Tardif; *Société canadienne des postes c. CALP*, 13 janvier 1988, D.T.E. 88T-377, Montréal (C.S.).

⁴ RLRQ, c. A-3.001.

maladie professionnelle ou qu'elle a subi une récurrence, rechute ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure.

[51] Rappelons que l'article 224 de la loi consacre le principe selon lequel la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge d'un travailleur en l'absence de recours à la procédure d'évaluation médicale. Par conséquent, le Tribunal, tout comme les parties, est lié par le diagnostic de tendinopathie du sus-épineux à l'épaule gauche posé par docteur Baril.

[52] La notion d'accident du travail au sens élargi et ce qu'elle implique pour un travailleur qui la soulève, entre autres en termes de fardeau de preuve, est bien résumée dans l'affaire *Rodrigue et Chemin de fer nationaux du Canada*⁵ :

[114] Les arguments du représentant du travailleur orientent le tribunal plutôt vers la notion élargie d'un accident du travail et c'est en fonction de ce concept qu'il convient d'analyser la réclamation du travailleur.

[115] À ce sujet, la jurisprudence⁷ considère que le concept des microtraumatismes associé à la notion élargie d'accident du travail ne fait pas double emploi avec celle de maladie professionnelle lorsque les gestes répétés ou à risques qui sont allégués par un travailleur sont circonscrits dans une période de temps limitée, souvent à la suite de modifications des conditions de travail. Lorsque ces microtraumatismes sont superposés, ceux-ci peuvent alors présenter le caractère imprévu et soudain requis et constituer un accident du travail au sens élargi de ces termes.

[116] Les modifications des conditions de travail à laquelle le tribunal fait référence peuvent faire suite à une surcharge de travail, une modification de tâches ou lorsque des conditions de travail inhabituelles sont présentes.

[117] Dans ce contexte, pour que ces modifications soient assimilées à un événement imprévu et soudain, il doit y avoir un changement majeur ou une situation qui sort véritablement de l'ordinaire par rapport au travail habituel⁸.

[118] Il est bien établi que le fardeau de preuve repose entièrement sur le travailleur qui invoque la survenance d'un événement imprévu et soudain au sens élargi. Celui-ci doit aussi démontrer qu'il existe une relation médicale causale entre la situation nouvelle au travail et la lésion diagnostiquée⁹.

[119] Aussi, il ne suffit pas de plaider l'existence de microtraumatismes. Il est nécessaire d'établir que ces microtraumatismes sont présents par la démonstration que les gestes sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion identifiée¹⁰.

[...]

[123] Même si le tribunal en venait à la conclusion que les changements intervenus au travail sont suffisamment significatifs, le travailleur doit tout de même démontrer qu'il est exposé à des mouvements à risque de causer une lésion professionnelle.

⁵ Précitée, note 3, révision rejetée, 5 avril 2015, M. Lamarre.

[Notes omises]

[53] Eu égard aux conditions de travail usuelles de la travailleuse, il est en preuve que cette dernière n'a pas à exécuter de mouvement de *flip* lorsqu'affectée à d'autres équipements que la machine Weber. En outre, il est démontré qu'elle fut affectée à titre d'inspectrice sur cette machine de manière continue à compter du 27 janvier 2014, et ce, jusqu'à son arrêt de travail du 14 mars.

[54] Il est également en preuve que la production sur les quarts de travail de jour et de soir, le 18 février 2014 a généré une quantité inhabituelle de sacs devant être rejetés, 2 111/19 275, soit un taux d'environ 11 %, alors que selon l'employeur le taux moyen est habituellement de 3 %. Il est de plus en preuve qu'il y aurait eu davantage de rejets sur le quart de soir, et que parmi les 2 111 rejets totaux, ne sont pas inclus ceux générés lors du *setup*, dont la quantité n'est toutefois pas déterminée.

[55] Partant de là, le Tribunal estime qu'il est démontré de façon probante que les conditions de travail de la travailleuse, à compter du 27 janvier 2014, étaient différentes de celles auxquelles elle est généralement exposée, et que la situation qui prévalait sur le quart de travail de soir le 18 février 2014 sortait de l'ordinaire.

[56] Ceci étant, la travailleuse devait démontrer qu'elle fut ainsi exposée à des mouvements à risque de développer une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche.

[57] Le Tribunal administratif du travail, en raison de son statut de tribunal spécialisé, sait qu'un mouvement d'abduction ou d'élévation antérieure du membre supérieur dans un angle de plus de 60°, maintenu en position statique de manière prolongée, ou exécuté de façon répétée, avec charge associée et cadence imposée, est à risque dans les cas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. À tout événement il y a tout de même lieu de référer à la littérature médicale déposée pour, de nouveau, identifier les facteurs de risque à considérer en pareil cas.

[58] Dans l'extrait tiré de *Pathologie médicale de l'appareil locomoteur*⁶, sous la rubrique *Tendinopathie de la coiffe des rotateurs et le travailleur*, il est permis de lire : « Le risque de tendinopathie à l'épaule serait principalement lié à des activités nécessitant le maintien de postures statiques, la manutention de charges et l'exécution répétée de mouvements de l'épaule ou de la main ». Il est de plus noté : « Le niveau de risque est considéré élevé pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs si la posture du bras en flexion ou en abduction est de plus de 60° ou si la fréquence de mouvements du bras se situe au-delà de deux par minute ».

⁶

Précitée, note 2.

[59] Les auteurs de l'ouvrage identifient et énumèrent ainsi les « *principaux facteurs de risque professionnels associés à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs* » :

- Postures répétées ou maintenues > 60° de flexion antérieure ou d'abduction
- Travail avec mouvements répétitifs des poignets ou des mains
- Travail avec la main plus haut que l'épaule
- Travail nécessitant des mouvements de rotation ou d'extension du bras

[60] Les auteurs indiquent en outre « *plus le bras est éloigné du corps, plus la charge mécanique sur l'articulation de l'épaule est importante, à cause de l'effet de bras de levier* ».

[61] Enfin, dans l'extrait déposé et tiré du site web du Gouvernement du Canada, l'on peut notamment lire « *les travailleurs qui doivent effectuer des mouvements très répétitifs jumelés à l'application d'une certaine force physique présentent souvent des troubles tendineux de l'épaule* ».

[62] De même, le Tribunal n'est pas sans savoir que l'exposition à un seul facteur de risque est généralement considérée comme peu significative dans les cas de troubles musculosquelettiques et qu'une combinaison de facteurs représente un risque plus élevé.

[63] En l'espèce, la preuve démontre de façon probante que le mouvement qu'incrimine la travailleuse, le *flip*, implique une flexion antérieure, abduction et rotation interne du membre supérieur gauche au-delà de 60°, soit tout près de 90°. Selon les auteurs, le niveau de risque est considéré pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs en présence d'un tel mouvement.

[64] Les auteurs *Bergeron Fortin Leclaire*⁷ écrivent que le niveau de risque est considéré pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs si la fréquence d'un pareil mouvement se situe au-delà de deux par minutes, alors que dans l'extrait tiré du site du Gouvernement du Canada il est fait état, sans le définir, de mouvements « très répétitifs ».

[65] En outre, la preuve démontre que durant son quart de travail le 18 février 2014, la travailleuse fut susceptible d'être exposée à ce mouvement à risque au cours d'une période de 480 minutes non consécutives, soit 210 minutes (3,5 h) de *run time* et 270 minutes (4,5 h) de *setup*.

[66] Considérant que 12 600 sacs furent produits au cours du quart de travail de soir le 18 février avec un taux de rejet de 11 %, qu'un paquet compte 12 ou 13 sacs, et que la travailleuse a travaillé durant 480 minutes, ceci signifie qu'elle a vraisemblablement

7

Précitée, note 2.

été amenée à *flipper* environ deux paquets à la minute, lorsqu'exposée. Ce qui s'approche considérablement de la fréquence que les auteurs précités considèrent à risque pour développer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Qui plus est, le mouvement était exécuté en tout temps avec une charge non négligeable de 2,24 kg, soit près de 5 lb. Aussi, il fut permis de constater lors du visionnement de la vidéo que lorsque la travailleuse exécute le mouvement de *flip*, elle éloigne généralement le membre supérieur gauche de son corps, augmentant ainsi la charge mécanique sur l'articulation de l'épaule.

[67] Le Tribunal est d'opinion que la preuve démontre donc de manière prépondérante que le soir du 18 février 2014, conformément à la littérature, la travailleuse a exécuté un mouvement à risque pour développer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs près de deux fois à la minute avec charge.

[68] Docteur Léger soutient que ce mouvement, malgré l'amplitude, ne va pas au-delà d'un geste physiologique, est entrecoupé de temps de repos suffisant, est exécuté sans posture contraignante et sans charge significative, de même qu'à l'intérieur d'un cycle de travail qui implique plusieurs gestes différents, diminuant ainsi le risque de développer une tendinopathie.

[69] Avec égards, sur la question de l'amplitude d'un mouvement à risque pour développer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, le Tribunal ne partage pas l'opinion du médecin de l'employeur. Comme précédemment mentionnée, la littérature enseigne que le mouvement (*flip*) exécuté par la travailleuse est à risque pour développer une telle pathologie au-delà de 60° et non de 90°. Quant à la question du poids, le Tribunal est d'opinion qu'une charge de près de 5 lb constitue une charge contraignante eu égard aux circonstances dans lesquelles le mouvement de *flip* fut posé le 18 février 2014. Ceci diminue la valeur probante de l'opinion du médecin aux yeux du Tribunal.

[70] Par contre, le Tribunal accorde tout de même une certaine valeur probante à l'opinion du docteur Léger puisque la preuve démontre qu'entre le 27 janvier et le 18 février la travailleuse a occupé le poste d'inspection sur la machine Weber sans douleur, étant d'ailleurs asymptomatique au début de son quart de travail à 15 h le 18 février.

[71] Cependant, ce que la travailleuse allègue comme étant à l'origine de sa lésion n'est pas le travail accompli avant le 18 février, mais plutôt le fait qu'en raison du taux de rejet extrêmement élevé le soir du 18 février 2014, ceci impliquait pour elle de consacrer davantage de temps à écarter les sacs abîmés, lui laissant par le fait même moins de temps pour exécuter le mouvement de *flip*, la forçant ainsi à l'exécuter avec plus de rapidité. Et selon toute probabilité, avec moins de soin ou d'attention.

[72] À cet égard, le Tribunal retient qu'il est démontré que lorsque confrontée au taux moyen de rejet de 3 %, soit entre le 27 janvier et le 18 février, et ce, indépendamment de la quantité de sacs produits, la travailleuse fut vraisemblablement en mesure d'exécuter le mouvement de *flip* à l'intérieur de ses capacités physiologiques, bien qu'il constitue un mouvement à risque pour développer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

[73] Mais le Tribunal estime qu'il est également démontré que le 18 février 2014, la travailleuse a fort probablement outrepassé ses capacités physiologiques parce que confrontée à un taux de rejet de près de quatre fois le taux moyen, la forçant ainsi à *flipper* les paquets de sacs à l'intérieur d'un intervalle de temps réduit et avec plus de rapidité.

[74] Autrement, comment expliquer qu'avant son quart de travail du 18 février 2014, elle soit demeurée totalement asymptomatique après des productions hebdomadaires respectives de 93 730, 53 040 et 71 350 sacs associées à un taux de rejet de 3 %, et qu'après une production de 12 600 sacs, le soir du 18 février, associée à un taux de rejet de 11 %, elle ait développé une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche, sinon en raison de la situation particulière qui prévalait ce soir-là.

[75] Quant à l'unilatéralité de la pathologie de la travailleuse, le Tribunal considère qu'elle peut s'expliquer par le fait que celle-ci soit droitière. De par son statut de tribunal spécialisé, le Tribunal sait qu'un individu possède généralement plus de force et d'endurance du côté dominant. L'on pourrait incidemment même aller jusqu'à considérer qu'il s'agit d'une connaissance d'office. De plus, dans une moindre mesure, et sans en faire un élément déterminant en raison de la preuve peu élaborée sur le sujet, il y a tout de même lieu de tenir compte du fait que la travailleuse a déjà présenté antérieurement une tendinite à l'épaule gauche laquelle, selon ce qu'écrit docteur Léger, avait été traitée par physiothérapie et duré plusieurs mois. Ce qui pourrait laisser croire à une certaine fragilisation à ce niveau.

[76] Enfin, quant aux délais de déclaration et de consultation, respectivement de deux et quatre semaines, le Tribunal ne les considère pas incongrus en l'espèce et ils ne permettent pas d'amenuiser la relation causale au point de venir la nier. D'une part, parce que la travailleuse a su très bien les expliquer et présente une grande crédibilité aux yeux du Tribunal. D'autre part, parce que sa version des faits est demeurée toujours constante, pointant invariablement au fil de ses déclarations les conditions prévalant le 18 février comme étant à l'origine de sa lésion à l'épaule gauche.

[77] Considérant que le 18 février 2014, conformément à la littérature, la travailleuse a exécuté un mouvement à risque pour développer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à une fréquence de près de deux fois à la minute avec charge lorsqu'exposée, associé à un taux de rejet anormalement élevé, le Tribunal juge qu'il existait donc une situation qui sortait véritablement de l'ordinaire et suffisamment significative pour

expliquer de façon probable l'apparition de sa lésion à l'épaule gauche, faisant en sorte que les autorités déposées par la procureure de l'employeur relatives à la non-application de la notion d'accident de travail au sens élargi, ne peuvent trouver application en l'espèce.

[78] Considérant l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal administratif du travail juge que la travailleuse a démontré de manière prépondérante avoir subi un accident du travail au sens élargi de cette notion le 18 février 2014.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la contestation de madame Sabrina Nadeau, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 12 septembre 2015 par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 18 février 2014.

Jacques Degré

Monsieur Bernard McNicoll
UNIFOR (S.D.A.T.)
Pour la partie demanderesse

M^e Lucie Guimond
GOWLING LAFLEUR HENDERSON SENCRL-SRL
Pour la partie mise en cause

Date de la dernière audience : 11 janvier 2016